

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	闌尾炎 Appendicitis				
編號	A31000-Q03-W-D05	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	98 年 03 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.8 版/7 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解闌尾炎的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

闌尾位於盲腸近迴盲瓣的下方，不具任何功能，因管徑很小，當要排空時很容易遭阻塞，闌尾阻塞是闌尾炎最常見的初始情況，糞石則是最常見的原因。闌尾的空腔阻塞後，會使管腔壓力上升，漸進式造成嚴重的上腹疼痛，幾小時後，便局限於右下腹，發炎的闌尾充滿化膿物質，最後則會發生壞死及穿孔，甚至引發腹膜炎。

（二）症狀

急性闌尾炎症狀出現到發作的時間，通常不超過 24 小時，平均都是在數小時內發作，臨床患者會有低度發燒($<38.5^{\circ}\text{C}$)、厭食、噁心、嘔吐。腹部疼痛先是在上胃部或肚臍周圍發生瀰漫性疼痛，一旦發炎現象擴展到整個闌尾的壁層腹膜，刺激到體壁痛神經纖維，疼痛則發生於右下腹部，2-12 小時後疼痛侷限在右下腹部，於麥氏點(McBurney's point)(肚臍與右腸骨嵴連線之中間處)出現壓痛現象，因疼痛而出現平躺且將右腿屈曲的保護性姿勢。腹部僵硬、腹脹、瀰漫性疼痛、

主題名稱	闌尾炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	2/7

反彈痛發生時，意謂發生腸穿孔引發腹膜炎。

(三) 常見檢查

1. 洛夫辛徵象(Rovsing's sign)(+)：觸壓左下象限會引發右下象限的疼痛。
2. 腰大肌徵象(Psoas's sign)(+)：病人左側臥，髖關節處彎曲右腳牽扯腰大肌，看病人右下腹是否會疼痛。
3. 白血球數增加，超過 $10,000/\text{mm}^3$ ，嗜中性白血球數升高，C-反應蛋白質指數也會在 12 小時後增加。若闌尾穿孔時白血球總數以及不成熟的白血球比例會增加。
4. 腹部 X 光：可能顯示糞石存在。

(四) 常見治療

1. 術前的準備：抽血、心電圖、胸部 X 光、麻醉科會診、告知禁食，最初應先給予靜脈注射等張性的液體，以達到充分的尿流量，並矯正電解質的不平衡。
2. 抗生素治療：未手術前使用廣泛抗生素的處方，以幫助控制局部的和全身性的敗血症，並減少術後傷口感染的機會。
3. 手術：行闌尾切除術或腹腔鏡闌尾切除手術。

(五) 護理問題

1. 疼痛不適／疾病。
2. 易感染／與腸道破裂引起腹膜炎及術後傷口有關。
3. 尋求（特定的）健康協助／與闌尾切除術前後知識不足有關。

(六) 護理措施

1. 疼痛不適／疾病

- (1) 運用疼痛評估量表(VAS)及 PQRST 評估疼痛情形並記錄疼痛的部位、性質和持續的時間。
- (2) 手術前依醫囑於下腹部使用冰敷，以減輕疼痛。疼痛時可教導將腿屈曲使腹肌鬆弛。
- (3) 依醫囑給予止痛劑、止吐劑和鎮靜劑，並觀察使用後效果。

主題名稱	闌尾炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	3/7

(4)經常給予口腔護理和潤濕嘴唇，以協助消除因脫水和禁食狀態引起的不適和噁心。

(5)術後協助身體清潔、翻身並給予背部按摩，協助採舒適臥位（屈膝）。

(6)教導病人進行緩慢的橫膈膜呼吸，以減低壓力及放鬆肌肉張力。

(7)手術後當天即鼓勵及協助下床活動。

2. 易感染／與腸道破裂引起腹膜炎及術後傷口有關

(1)密切觀察疼痛是否加劇及廣泛性發生，並注意是否發生持續性嘔吐，病人是否採側臥或平躺將腿屈曲等舒適臥位。

(2)監測是否發生體溫升高、脈搏速度加快、血壓降低、呼吸變淺且快的情形。

(3)評估腹部是否發生如木板般僵硬、反彈痛、脹氣、腸蠕動音減弱或消失等現象，若發生上述情況，立刻向醫師報告。

(4)每班觀察傷口外觀及引流液的量、顏色、味道及濃稠度並紀錄。

(5)於術前及術後數週內，避免灌腸和腹部熱敷，以免發生腸道破裂情形。

(6)依醫囑給予抗生素。

3. 尋求（特定的）健康協助／與闌尾切除術前後知識不足有關

(1)手術前為減輕症狀，需禁食。

(2)告知避免腹部熱敷及勿隨意服用止痛劑的重要性。

(3)術後需等腸蠕動恢復正常，才可進食流質食物如米湯、果汁，若無嘔吐、腹脹情形，就可以開始嘗試吃稀飯、蒸蛋，接著再麵條或乾飯。勿進食過甜、過多牛奶及豆製品，因會引起腹脹，若未出現噁心、嘔吐、腹脹，可逐漸改為普通飲食。

(4)如果闌尾穿孔，手術後腹腔會插引流管，需要注意引流液的量、顏色、味道及濃稠度，如果發現量很多或不一樣的情形時，應告訴醫護人員，以便進一步處理。

(5)術後需避免弄濕傷口，以免造成感染，且咳嗽或大笑時均需按壓傷口，以免引起疼痛及造成傷口裂開。

主題名稱	闌尾炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	4/7

(6)鼓勵並協助病人床上翻身及早期下床活動，以利維持正常的腸蠕動。

(7)教導傷口護理，包括避免弄濕、弄髒及換藥技術。告知傷口感染的徵象：發燒、寒顫、傷口痛、發紅、腫脹和化膿性分泌物等，若出現上述現象，需立刻就醫。

(8)術後 6 週避免提重大於 5 磅（2 公斤以上）的物體，並避免灌腸，以免傷口裂開或造成傷口疝氣。

（七）衛教指導

闌尾切除術後病人須知

- 1.採半身麻醉者，手術後需平躺八小時，不可睡枕頭及抬頭。
- 2.醫師術後會依病人腸蠕動恢復的狀況，如已排氣會給予漸進性飲食（由清流質至流質再到軟質，最後恢復普通飲食）。
- 3.手術後第一天即可採漸進式下床活動。
- 4.保持傷口乾燥、清潔，如傷口需拆線則在醫師指定時間回診。
- 5.術後需避免弄濕傷口，以免造成感染，且咳嗽或大笑時均需按壓傷口，以免引起疼痛及造成裂開。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

主題名稱	闌尾炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	5/7

六、參考資料

- (一) 周繡玲(2024)・消化系統疾病之護理・成人內外科護理（九版，下冊 16 章）・臺北：華杏。
- (二) 馮容芬、郭淑芬、林小玲(2022)・消化系統疾病與護理・新編內外科護理學（七版，12 章）・台北：永大。

七、附件

(略)

主題名稱	闌尾炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	6/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.03.31	1.0	新制定	98 年 03 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	增加護理措施：每班觀察傷口外觀及引流液的量、顏色、味道及濃稠度並紀錄	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	(1)醫護部改護理部 (2)說明部份修辭	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31.	3.1	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	新增參考文獻出處於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	3.3	第三項第四目內容說明修訂	107 年 06 月 13 日護理長會議通過
107.09.12	3.4	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.5	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.05	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	闌尾炎	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D05	版本	第 3.8 版	頁碼/總頁數	7/7

修正日期	版本	修正說明	備註
111.09.06	3.6	1. 第三項第三目內容修改。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 第六項增加參考資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.7	1. 第三項第五目之 3、第六目之 3.護理問題修正。 2. 刪除年限較久之第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.8	第六項參考資料文獻更新。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。